

OBSTRUÇÃO — DESCOMPRIMIR, RESSUSCITAR, OPERAR O ESTR

ALTA vs BAIXA E CAUSAS PRINCIPAIS

Aspecto	Delgado (alta)	Cólon (baixa)
Causas mais comuns	Bridas/aderências (1a), hérnias, tumor de delgado	Câncer colorretal (1a), volvo, diverticulite
Vômitos	Precoces e biliosos	Tardios, podem ser fecaloides
Distensão	Menos intensa	Mais intensa
Dor	Cólica periumbilical	Cólica em abdome inferior
Imagem	Alças delgadas dilatadas, níveis hidroaéreos centrais	Cólon dilatado periférico, 'grão de café' no volvo
Parada de eliminação	Pode ser tardia	Precoce (gases e fezes)

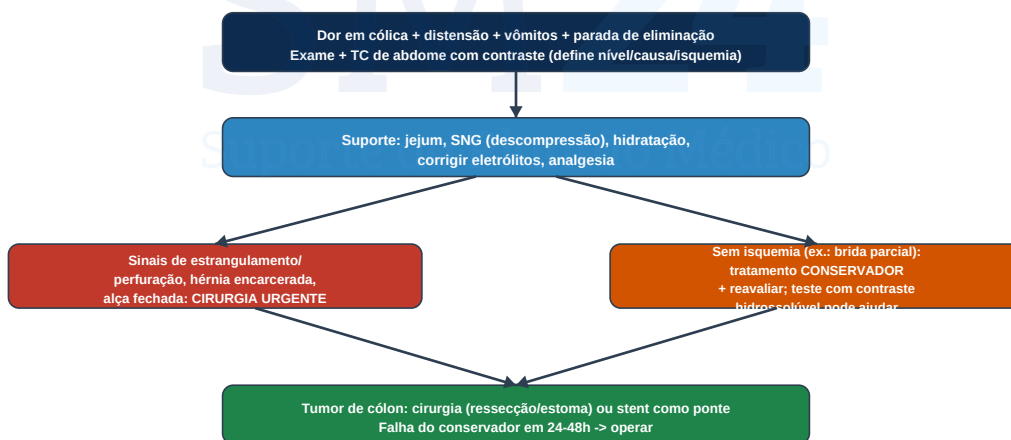
O QUE NÃO PODE PASSAR DESPERCEBIDO

ESTRANGULAMENTO = CIRURGIA URGENTE

- Sinais de estrangulamento/isquemia: dor contínua e intensa (não mais em cólica), febre, taquicardia, leucocitose, acidose/lactato elevado, irritação peritoneal
- Hérnia encarcerada irreductível e dolorosa = explorar com urgência
- Volvo de sigmoide/ceco: risco de isquemia — desvolvulação endoscópica (sigmoide) ou cirurgia
- Obstrução em alça fechada: alto risco de isquemia rápida
- Pneumatose, gás portal ou pneumoperitônio na imagem = emergência cirúrgica
- Na dúvida entre tratamento conservador e cirurgia, os sinais de sofrimento de alça inclinam para operar

ABORDAGEM DA OBSTRUÇÃO INTESTINAL

OBSTRUÇÃO — RESSUSCITAR + DECIDIR CIRURGIA



BRIDAS vs TUMOR — DECISÃO

Aspecto	Bridas/aderências	Tumor (côlon)
Contexto	Cirurgia abdominal prévia (causa mais comum no delgado)	Idoso, perda de peso, alteração do hábito intestinal, anemia
Conduta inicial	Muitas resolvem com tratamento CONSERVADOR (SNG, hidratação)	Geralmente exige tratamento cirúrgico/endoscópico
Tempo de observação	24-48h; teste com contraste hidrossolúvel (gastrografina)	Não retardar se obstrução completa/sofrimento
Cirurgia	Indicada se estrangulamento, alça fechada ou falha do conservador	Ressecção; estoma ou stent como ponte conforme o caso
Sinal de alarme comum	Piora da dor, febre, leucocitose, lactato = operar	Mesmos sinais de isquemia indicam urgência

SUPOORTE E SITUAÇÕES ESPECIAIS

Medidas de Suporte

- Jejum + sonda nasogástrica (descompressão e alívio de vômitos)
- Hidratação vigorosa e correção de distúrbios (hipoK, alcalose por vômitos)
- Analgesia e antiemético
- Sondagem vesical para controle de diurese
- Antibiótico se suspeita de isquemia/perfuração/seps
- Reavaliação clínica seriada (a evolução guia a decisão)

Diferenciais e Pseudo-obstrução

- Íleo paralítico (adinâmico): sem ponto de obstrução mecânica; tratar a causa
- Pseudo-obstrução colônica (Ogilvie): dilatação maciça sem obstrução mecânica
- Volvo de sigmoide: desvolvulação endoscópica se sem isquemia
- Hérnia encarcerada: examinar todos os orifícios herniários
- Bezoar, intussuscepção, corpo estranho
- Sempre examinar cicatrizes e regiões herniárias

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Diagnóstico clínico + TC de abdome com contraste (nível, causa e sinais de isquemia)
- ☐ Suporte: jejum, SNG, hidratação, correção de eletrólitos, analgesia
- ☐ Buscar sinais de estrangulamento (dor contínua, febre, leucocitose, lactato, peritonite)
- ☐ Estrangulamento/alça fechada/hérnia encarcerada/perfuração = cirurgia urgente
- ☐ Bridas sem isquemia: tratamento conservador 24-48h (teste com contraste hidrossolúvel)
- ☐ Tumor de cólon: cirurgia ou stent como ponte; operar se falha do conservador

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com cirurgia abdominal prévia, dor em cólica, distensão e vômitos, sem febre, leucocitose ou sinais de isquemia. TC sugere obstrução parcial por brida. Qual a conduta inicial?

- A) Laparotomia imediata
- B) Tratamento conservador (jejum, SNG, hidratação) com reavaliação em 24-48h
- C) Colonoscopia de urgência
- D) Alta com analgésico
- E) Antibiótico oral e dieta livre

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a causa mais comum de obstrução do intestino DELGADO?

- A) Câncer colorretal
- B) Bridas/aderências (pós-operatórias)
- C) Volvo de sigmoide
- D) Diverticulite
- E) Hérnia de hiato

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual achado indica estrangulamento e necessidade de cirurgia urgente na obstrução intestinal?

- A) Dor em cólica intermitente que alivia
- B) Dor contínua e intensa, febre, taquicardia, leucocitose e lactato elevado (sinais de isquemia/peritonite)
- C) Vômitos isolados
- D) Distensão leve sem outros sinais
- E) Eliminação de gases preservada

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Idoso com obstrução baixa, perda de peso, anemia e alteração do hábito intestinal. Qual a causa mais provável?

- A) Bridas
- B) Câncer colorretal
- C) Íleo parálítico
- D) Hérnia inguinal
- E) Bezoar

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente com volvo de sigmoide sem sinais de isquemia. Qual a conduta inicial preferida?

- A) Ressecção cirúrgica imediata para todos
- B) Desvolvulação endoscópica (descompressão), reservando a cirurgia para isquemia/recorrência
- C) Apenas observação
- D) Antibiótico isolado
- E) Enema opaco terapêutico repetido

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Obstrução parcial por brida, sem sinais de isquemia, em paciente com cirurgia prévia: a maioria resolve com tratamento conservador (jejum, SNG, hidratação, correção de eletrólitos) e reavaliação em 24-48h. O teste com contraste hidrossolúvel pode prever a resolução. Operar se surgirem sinais de sofrimento ou falha.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

As bridas/aderências (geralmente pós-operatórias) são a causa mais comum de obstrução do intestino delgado. Por isso é fundamental investigar o antecedente de cirurgia abdominal.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Sinais de estrangulamento/isquemia — dor contínua e intensa (não mais em cólica), febre, taquicardia, leucocitose, lactato elevado e irritação peritoneal — indicam sofrimento de alça e necessidade de cirurgia urgente.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Idoso com obstrução baixa associada a perda de peso, anemia e alteração do hábito intestinal tem como causa mais provável o câncer colorretal, que é a principal causa de obstrução do cólon.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

No volvo de sigmoide sem sinais de isquemia, a conduta inicial preferida é a desvolvulação endoscópica (descompressão), que resolve o quadro agudo. A cirurgia fica reservada para casos com isquemia, falha da desvolvulação ou recorrência (sigmoidectomia eletiva).

SM24
Suporte ao Plantão Médico